Diskussion 765

Datum: 1935-06-06
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 3
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: [1] kvinna-ord, [2] släktskaps- och tilltalsord, [3] yrkestitlar.

1. Alfred Petren (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Jag har begärt ordet i anledning av det anförande, som hölls av en ärad representant på Hallandslänsbänken, och skall nu be att på ett par punkter få bemöta vad han där yttrade.

Vad först beträffar hans erinran mot, att distriktssköterskorna skulle ha någonting med bostadsvården att göra, har jag följande att anföra.

Då enligt detta förslag, som ju syftar till att arbeta för en förbättrad social hygien — en för folkhälsans synnerligen betydelsefull strävan — en av de viktigaste uppgifterna för distriktssköterskorna skall vara att ha en upplysande och rådgivande verksamhet och att på det sättet arbeta för den personliga hälsovården, så är det otänkbart, att de kunna avkopplas från bostadsvården. Det är givet, att i alla de fall, där man finner bostadsförhållandena innebära en hälsofara eller medverkande orsak till sjukdom, det bör av dem beaktas, så att de då lämna råd och upplysningar, men det kan väl inte vara nog med att lämna råd och upplysningar, ty om dessa icke följas, så böra de väl ändå få göra en anmälan till hälsovårdsnämnden, vilken är den myndighet, som därvidlag har att ingripa. Det är, som det framhålles i propositionen, av vikt att det blir en kontinuerlig övervakning av bostadsförhållandena, och det sker på bästa sätt och billigaste sätt genom att använda den organisation, som man redan har, nämligen distriktssköterskeinstitutionen.

Som det också betonas av utskottet, så skall ju deras verksamhet inte vara av direkt fiskalisk art, utan som sagt huvudsakligen upplysande och rådgivande, das i nödfall skola de göra anmälan till vederbörande kommunala myndigheter.

Det var emellertid framför allt den ärade Hallandsbänksrepresentantens yttrande i dispensärfrågan, som uppkallade mig. Jag vill fästa uppmärksamheten på, att Kungl. Maj:ts förslag inte innebär en obligatorisk sammanslagning av distriktssköterskornas arbete och dispensärvården, utan det skall endast ske i den mån, som det inte behöves särskilda dispensärsköterskor. Jag medgiver, att den särskilt från tuberkulosläkarhåll framförda uppfattningen, att denna proposition inte borde ha framlagts förr än det även blivit framlagt en proposition angående dispensärvårdens omorganisation, icke alldeles sakna fog. Emellertid har ju Kungl. Maj:t uti sin proposition kunnat upplysa om det förslag till omorganisation av dispensärvården, som medicinalstyrelsen framlagt, och vid sådant förhållande synes det mig,

som om det inte borde vara något hinder att nu besluta den viktiga omorganisation, som denna proposition innehåller. Ty vi veta nu av medicinalstyrelsens därstädes refererade förslag, att det är meningen, att dispensärsköterskorna skola vara kvar där det behöves.

Vi veta vidare, att det föreligger det betydelsefulla förslaget, att det i varje län skall finnas en särskild A-dispensär, utrustad med röntgen, och att denna skall ha en i tuberkulossjukvård fullt utbildad och kompetent läkare. Det har ju en stor betydelse att få en sådan läkare för dispensärverksamheten i varje län. Kungörelsen angående statsbidrag till distriktsvård innehåller nämligen den bestämmelsen, att det i distriktsvårdsstyrelsen bör vara en läkare med särskild utbildning i tuberkulossjukvård. Då är det ju helt naturligt, att läkaren vid A-dispensären utses till ledamot av distriktsvårdsstyrelsen. Kungl. Maj:t hade ju föreslagit, att medicinalstyrelsen skulle utse en ledamot i denna, och jag får medgiva, att jag tycker, att denna ordning hade inneburit en synnerligen stor fördel med hänsyn därtill, att man kunde vara övertygad om, att medicinalstyrelsen skulle bevakat detta intresse, att det även bleve en tuberkulosvårdsläkare i distriktsvårdsstyrelsen. Emellertid kvarstår ju enligt utskottets förslag, i vilket denna rätt för medicinalstyrelsen är utesluten, dock den bestämmelsen, att det bör finnas en tuberkulosvårdsläkare i distriktsvårdsstyrelsen, och då får man väl utgå från, att landstingen skola visa sig angelägna om att även insätta en sådan läkare i denna styrelse. Särskilt har detta betydelse för ett sådant län som Hallands län med hänsyn till den organisation, som där är införd, med länet indelat i ett antal mindre områden med var sin dispensärsköterska.

Den ärade representanten på Hallandslänsbänken klagade över, att förslaget innebär, att denna organisation nu måste brytas. Så torde dock inte vara förhållandet, ty det är i den ifrågavarande kungörelsens $ 5 mom. 2 sista punkten sagt, att distriktssköterskas tjänstgöring kan omfatta allenast viss eller vissa grenar av sådan sjukvård, som kan utövas i hemmen, och vidare heter det i $ 4 sista punkten, att »På framställning av distriktsvårdsstyrelse må dock medicinalstyrelsen förordna annan läkare att vara förman för distriktssköterska». Tack vare dessa bestämmelser kan medicinalstyrelsen alltså medgiva, att man i ett län med den organisation av dispensärvården, som Hallands län har, kan fortsätta med särskilda dispensärsköterskor, som bli distriktssköterskor, och som till förman kunna få en tuberkulossjukvårdsläkare. Givetvis blir det den för dispensärverksamheten i Hallands län nu anställde läkaren som blir läkare vid A-dispensären, och då är det väl helt naturligt, att han blir utsedd till förman för dispensärsköterskorna. Jag har alltså härmed velat fästa uppmärksamheten på, att medicinalstyrelsen kan med stöd av dessa paragrafer bifalla, att Hallands län får bibehålla sin nuvarande organisation för dispensärvården, vilken de — enligt vad jag har mig bekant — gärna önska att få fortsätta med, eftersom den visat sig ha goda verkningar.

I anledning av den motion, som utskottets ärade vice ordförande yrkade bifall till, vilken motion går ut på att staten skulle lämna större bidrag till distriktssköterskorna, så att landstingets kostnader kunde bli mindre, må till sist nämnas att i motionen gjorts en felaktig

beräkning beträffande de utgifter, som skulle komma på landstingen i anledning av Kungl. Maj:ts förslag. Det säges nämligen i denna motion, att med en kontant medellön på 1,900 kronor per **sköterska³** och år blir landstingets årliga utgift härför 98,800 kronor. Det är emellertid inte riktigt, ty staten skall ju bidraga med 1,000 kronor jämte ålderstillägg. Alltså blir beträffande själva lönen landstingets bidrag aldrig mer än 800 kronor, och således skulle för det antal **sköterskor³** av 52, som är beräknat i propositionen för Kronobergs län, med en **sköterska³** per 3.000 invånare, landstingets årliga utgift för distriktssköterskornas löner ingalunda bli 98,800 kronor utan 41,600. Jag för min del skulle naturligtvis gärna unna landstinget det större statsbidraget, men helt naturligt drar man sig för att utan synnerligen starka skäl frångå vad Kungl. Maj:t föreslagit i fråga om

Ang. ändring i hälsovårdsstadgan. (Forts.) statsutgifter, och jag kan därför inte våga biträda den ifrågavarande reservationen, utan får jag, herr talman, be att med dessa ord få yrka bifall till andra punkten i utskottets hemställan.

2. Wilhelm Björck (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Endast några få ord till komplettering av vad som anförts här från olika håll till stöd för den kungliga propositionen.

Då det från Hallandsbänken nyss yppades farhågor för att förslaget skulle innebära en överorganisation, så är det skäl i att understryka, vad departementschefen anfört om siffran 3,000, nämligen att landstinget med utgångspunkt från densamma har full frihet att vid uppgörande av plan för distriktsvårdens utbyggande beakta geografiska och andra lokala förhållanden. Detta har utskottet också understrukit, och jag vill särskilt betona, att det inte rör sig om en platonisk deklaration från Kungl. Maj:ts sida. Det har verkligen förelegat meningsskiljaktigheter mellan medicinalstyrelsen och landstingen på det område, som motsvarar det nu ifrågavarande. Representanten för Gotland kan vitsorda, att medan det från medicinalstyrelsens sida krävdes, att distriktssköterskorna på Gotland skulle bli 11 eller 13, vilket det nu var, i varje fall minst 11, så godkände Kungl. Maj:t landstingets uppfattning, att man kunde nöja sig med en organisation, som omfattade 5 distriktssköterskor, och erfarenheten skulle få ge vid handen, huruvida man behövde fler. Kungl. Maj:t har alltså därmed markerat, att man skall gå empiriskt fram här och inte schablonmässigt binda sig för en viss organisation med risk att vederbörande **sköterskor³** inte få tillräckligt att göra. När det från Hallands sida påpekas, att man inte behöver sjukvikarier, beror det uppenbarligen på att man från början har gjort organisationen alltför omfattande. Erfarenheten ger vid handen, att efterhand som människorna lära känna fördelen av att utnyttja distriktssköterskorna i sjukvården, så få dessa alltmer och mer att göra, men det motiverar ju inte, att man från början kör i gång med en alltför stor organisation. Den saken tror jag är av betydelse att hålla i minnet.

För resten skall jag, herr talman, med hänsyn till den sena timmen inte yttra mig vidare, utan ber att få instämma i det yrkande, som framställts av herr Petrén.

3. Anders Johan Bärg (Socialdemokraterna, man)

Jag vet, herr talman, att man inte har rättighet att spilla tid här, men jag kan inte låta detta tillfälle gå förbi utan att uttala mina synnerliga betänkligheter mot det föreliggande förslaget. Detta mitt uttalande behöver ju inte tillmätas något värde, och man kan avfärda det med att jag inte begriper dessa saker. Jag kan dock få lov att säga, att det landsting, jag tillhör, var bland de första, som organiserade distriktsvården. Jag vill minnas, att vi nu ha 35 anställda distriktssköterskor och därutöver 3 dispensärsköterskor. Jag har varit i tillfälle att följa denna verksamhet alltifrån dess planläggning, jag har följt organisationens genomförande och alltjämt stått den så nära som en ledning kan och har skyldighet att följa verksamheten.

Jag skall med hänsyn till den beklagligt knappa tiden inskränka mig till att säga, att det är två ting, som jag här reagerar mot. Det ena är den uppgift, man vill ge distriktssköterskorna som övervakare av bostadsförhållandena. Jag har alltjämt litet svårt att få något grepp på vilken uppgift **sköterskorna³** skola ha. Departementschefen säger en sak, medicinalstyrelsen säger något annorlunda, herr Carlsson i Gävle har sagt ytterligare något annat och det är att deras uppgift är att tillse, att bostäderna vårdas och barnen skötas. Det är väl inte det, som man nu som nytt vill ålägga **sköterskorna³** och som man anmärker på; det är den vanliga hemvården. som dessa skö-

Jag menar med detta, herr talman, att med den ställning, **sköterskorna³** intaga, äro de näppeligen skickade att gripa in på ett område som detta. Jag föreställer mig, att det skall gå till ungefärligen på följande sätt, om **hon²** skall spela någon roll. När — jag tar det endast som exempel — på ett av våra större gods i Södermanland låt oss säga statarna gång efter annan ha gjort framställning hos vederbörande om bättre bostäder, vilket av olika skäl har avvisats, så vända de sig till **sköterskan³**, när **hon²** nu pålägges skyldighet att ingripa. **Hon²** är väl då piskad att gå till vederbörande och göra föreställningar om att denne inte vårdar sig om sitt folk och dess bostäder på sätt som är lämpligt. Är det så, att **hon²**, som det står i propositionen, lyckas lägga detta till rätta, så är det ju bra. Lyckas **hon²** inte — och jag föreställer mig, att det kommer att uppstå rätt många sådana fall, ty det är inte okunnighet om bostadsinnehavarnas önskan, som gör, att bostäderna inte äro i lämpligt skick, utan det beror på andra skäl — så har **sköterskan³** intet annat att göra än att säga till vederbörande bostadsägare: Ja, då måste jag vända mig till hälsovårdsnämnden. Det skulle inte förvåna mig, om **hon²** då får det svaret: Välkommen, **syster²** lilla, där sitter jag ordförande! **Sköterskan³** har vidare, då hälsovårdsnämnden lämnar anmälan utan avseende, inte annat att göra än att rapportera till styrelsen och till läkaren, och skola de ingripa för att råda bot.

Jag menar med detta, att själva metoden är sådan, att **sköterskan³** kommer mot sin vilja att tvingas in i sociala tvistigheter mellan olika intresseparter, och det är inte lämpligt att draga in en tjänande sjuksyster däri. Nu är det

Jag ber utöver detta bara att få säga, att jag tycker, att det inte är klokt att dela upp sjukvårdsledningen på sätt som här är föreslaget, när man förut har sökt att sammanföra det i

en hand för att få det hela lämpligt ordnat. Detta finner jag synnerligen oklokt.

Nu förstår jag, herr talman, att den här saken är det för närvarande ingenting att göra åt. Jag sticker dock inte under stol med att Jag tror, att det bästa hade varit, om förslaget icke hade kommit fram i den form, vari det nu föreligger. Men jag skall dock under för handen varande omständigheter icke göra något lönlöst yrkande, utan jag skall sluta med att önska, att mina farhågor icke äro befogade. Bättre rekommendation kan jag icke ge denna fråga vid dess start.